



ÉVÉNEMENT INDESIRABLE GRAVE DECES



ACTIONS DE SOINS

ASSURER LA SÉCURITÉ (stabilisation / récupération) DU PATIENT

- ☐ PRENDRE EN CHARGE IMMÉDIATEMENT LE PATIENT ET ASSURER SA SÉCURITÉ
 - Renfort
 - Leader
 - Aides cognitives
- ☐ FAIRE LES PRÉLÈVEMENTS nécessaires pour étayer le diagnostic
- ☐ TRACER toutes les actions dans le dossier médical

ACTIONS D'ÉQUIPE

IMMÉDIAT : RETRACER LE DÉROULEMENT DES ÉVÈNEMENTS

- ☐ Extraire le personnel concerné de l'activité (si possible) – Ecoute par des pairs – Débriefing à chaud
- ☐ Signaler l'événement selon la procédure (chef de service, cadres de santé)
- ☐ Proposer un accompagnement psychologique et/ou matériel aux équipes
- ☐ Déclencher le protocole seconde victime*

PRÉPARER LA RENCONTRE AVEC LE PATIENT OU LES PROCHES

- ☐ Briefing sur les faits, les protocoles existants pour avoir un discours d'équipe (rapport factuel)
- ☐ Qui sera présent ?
 - Médecins impliqués ou non, mais jamais seul (anesthésistes, réanimateurs, opérateurs)
 - Si possible : accompagnés (chefs de service, confrère, cadre)
 - +/- paramédicaux
- ☐ Qui parle?
- ☐ Où (pièce dédiée, assis) ?
- ☐ Quand ? Comment?
- ☐ Au calme - Pas d'interruption
- ☐ Dossier patient – perspectives de suivi (contacts ultérieurs nécessaires)

À DISTANCE

- ☐ Assurer un retour à toute l'équipe et si besoin à la direction
- ☐ Écrire dans le dossier ce qui a été dit (procédure d'annonce d'un EIG)
- ☐ Organiser les modalités d'analyse (RMM, actions correctrices si besoin)
- ☐ Définir les modalités de suivi de la relation
- ☐ Proposer un soutien psychologique des personnes impliquées
- ☐ Signaler l'événement selon la procédure (direction, gestionnaire de risque, ARS)

Références:

- Institut canadien pour la sécurité du patient

- Événement indésirable grave – Parlons-en. Guide pratique à l'attention des équipes hospitalières. Assistance Publique Hôpitaux de Paris Hobgood C, Haward D, Newton K and Davis W. The educational intervention « GRIEV_ING » improves the death notification skills of residents. Acad Emerg Med 2005; 12(4):296-301

- Annonce d'un dommage associé aux soins - Information du patient - Outil d'amélioration des pratiques professionnelles - Mis en ligne le 10 janv. 2011: https://www.has-sante.fr/jcms/c_953138/fr/annonce-d-un-dommage-associe-aux-soins

* Seconde victime. Comité Vie Professionnelle – Santé au travail. <https://sfar.org/wp-content/uploads/2022/05/FicheSecondeVictime2022.pdf>



EVENEMENT INDESIRABLE GRAVE DECES



COMMUNICATION AVEC LES PROCHES

1 Préparer le rendez-vous d'annonce

- Quels sont les faits dont on est sûr ?
- Qui assistera au RDV ?
- Quand et où se tiendra le RDV ?
- Quels sont les besoins prévisibles du patient ?

2 Réaliser l'annonce

- Reconnaître le dommage
- Communiquer sur des faits connus et sûrs
- Exprimer des regrets voire des excuses
- Décider du plan de soins en concertation avec le patient
- Répondre aux besoins du patient
- Proposer un référent
- Tracer l'annonce dans le dossier médical
- Débriefing en équipe ou participer à des démarches collectives d'analyse des pratiques

3 Suivre l'annonce

- Informer le patient des nouveaux éléments connus
- Exprimer de nouveau des regrets voire des excuses en cas d'erreur avérée
- Mettre en œuvre les offres de soins et de soutien proposées
- Organiser avec le patient les soins d'aval
- Tracer les rendez-vous de suivi dans le dossier médical

À ÉVITER

- ☐ Rester isolé alors qu'un soutien extérieur serait nécessaire.
- ☐ Refuser que le patient soit accompagné lors de l'entretien d'annonce du dommage.
- ☐ Manifester de l'agressivité.
- ☐ Utiliser le jargon médical - Spéculer sur les faits.
- ☐ Blâmer une personne.
- ☐ Nier ou dissimuler le dommage du patient.
- ☐ Culpabiliser le patient.
- ☐ Nier sa propre responsabilité le cas échéant.
- ☐ Fournir au patient des informations contradictoires.